

+ 医知創造ラボ

鼻水の色では、 決まりません

大人の副鼻腔炎に、抗生物質は必要か

大人の副鼻腔炎

監修：脳神経内科医

大人の副鼻腔炎、3つのポイント

1 抗生物質が要る人・要らない人

その線引きの考え方

2 すぐ受診すべきサイン

「目のまわり」と「おでこ」

3 「蓄膿の頭痛」の正体

脳神経内科医の視点から

顔の骨の中にある「空洞」です



かぜで鼻の粘膜が腫れると通り道が狭くなり、中に分泌物がたまって炎症が起きます。

大人の急性副鼻腔炎の多くは、かぜの延長線上にあります。

続いた期間で、3つに分けます

続いている期間	国際的な呼び方
10日未満	「かぜ」
5日を過ぎて悪化、または10日を超えて続く	「かぜのあと」
12週(約3か月)を超える	「慢性」

10日を超えたものについての名前は「細菌性」ではありません

鼻水の色では、区別できません

 厚生労働省『抗微生物薬適正使用の手引き』第四版(2026年)

鼻汁の色だけでは、
ウイルス感染症と細菌感染症との区別はできない

黄色い。緑がかっている。粘り気がある。
どれも「細菌がいる証拠」にはなりません。

感覚に反しますが、その直感を裏づける根拠が見つかっていません。

「効く人」も、見分けられませんでした

大人の副鼻腔炎について、抗生物質と偽薬を比べた質の高い試験を集め、一人ひとりのデータをまとめ直した研究があります。

その結果

症状や背景から、抗生物質で得をする人と、得をしない人を見分けることはできませんでした。

■ 誤解しないでください **IMPORTANT**

07

ここは、正確にお伝えします

× 「抗生物質は誰にも効かない」と証明された

○ 効く人はいる。ただし、その人を先に選び出す方法が、まだ見つかっていない

「10日」は、何の線なのか

国際的な分類では、10日を超えて続くものに「ウイルスのあと」という名前がついています。

 その文書に書き添えてあること

これは、細菌感染に進んだ印ではない

見分けられるから引いた線ではなく、
どこかで線を引く必要があるから引かれた線です。

それでも「要る人」はいます

- ☐ 高い熱が出ている
- ☐ 痛みが強い
- ☐ いったん良くなったのに、また悪くなった

こうした場合は、細菌感染を疑う理由になります。

 国内の手引きでは

軽症なら5日ほど様子を見て、中等症以上では抗生物質を検討します。

■ THE BIG QUESTION

いちばん引っかかるのは、ここだと思います

「飲まないと、
こじらせませんか？」

この不安には、はっきりした答えがあります。

合併症は、いつ起きるのか

副鼻腔炎には、目のまわりや脳のほうへ炎症が広がる合併症があります。

まれです。ただし、まれというだけで、ゼロではありません。

その合併症は、病気の早い時期に起きます。

抗生物質を広く処方しても、その数は減っていません。

- 今日いちばん伝えたいこと **THE POINT**

「念のため抗生物質」では、 この合併症は防げません

防ぐ方法

「このサインが出たら、すぐ受診する」と知っておくことです。

これが、今日いちばんお伝えしたいことです。

■ 🚨 すぐ受診のサイン ①

覚え方は「目のまわり」と「おでこ」

まず、「目のまわり」から。



目のまわりが
腫れる・赤くなる



目が動かしにくい
ものが二重に見える



見えにくくなる



眼球が前に
押し出される

■ 🚨 すぐ受診のサイン ②

「おでこ」と、その他のサイン



おでこが腫れる



おでこの強い痛み



意識がぼんやりする



首が硬い・けいれん
手足が動かしにくい



新しく出た
「片側だけ」の症状



見え方の異常や意識の変化は、夜間・休日でも待たない

飲まなくても、治っていきます

見通しが立たないことが、この病気のつらさの半分だと思います。

1週間

半分ほどの方が治る



2週間

3分の2ほどの方が治る

抗生物質で治りが早くなる方はいますが、その割合は多くありません。

その一方で、嘔吐・下痢・腹痛などの副作用は確実に増えます。

効き方の強さで、仕分けます

やること	効き方	ひとこと
点鼻のステロイド薬	効く寄り	ただし効果の大きさは控えめ
鎮痛薬	使ってよい	痛みには素直に使ってかまわない
鼻うがい	弱い	大人での効果ははっきりしない
蒸気の吸入	未確定	効くとも、害があるとも言えない

■ ひとつだけ注意 CAUTION

市販の点鼻薬は「10日」まで

市販の点鼻薬には、鼻の血管を縮めて、
通りをよくするタイプがあります。

よく効きます。ただし使い続けると、
かえって鼻づまりがひどくなることが知られています。

10日を超えて使い続けないでください。
効くからこそ、手放せなくなる薬です。

■ CHAPTER — SINUS HEADACHE

脳神経内科医として、最もお伝えしたい話です

「蓄膿の頭痛」は もう使わない言葉

二つのまったく違うものに使われてきたからです。

— 国際頭痛分類 第3版(2018年)

片頭痛でも、鼻水や涙は出ます

片頭痛の発作のときには、鼻がつまったり、鼻水が出たり、涙が出たりすることが珍しくありません。

日本人を対象にした調査でも報告されています。

顔の片側が痛い。鼻がつまる。鼻水が出る。これだけ並べば、誰でも副鼻腔炎だと思います。

ただし、反対側に振り切らない

- ✓ 副鼻腔炎で頭痛は起きる。国際頭痛分類でも認められています
- ✓ 逆に、副鼻腔の状態が片頭痛の引き金になることもあります
- ✓ 画像で白く写っていても、それだけで原因とは言えません

大事ななのは、どちらかに決めつけないことです。

12週を超えたら、耳鼻咽喉科へ

12週を超えて続くと、慢性副鼻腔炎という別の扱いになります。

- ☐ 12週(約3か月)を超えている
- ☐ 新しく出てきた「片側だけ」の症状がある
- ☐ においが分からない状態が続いている
- ☐ 上の奥歯に心当たりがある

大人では、原因が歯にあることも少なくありません。

今日の持ち帰りポイント

- ✓ 鼻水の色では、抗生物質が必要かどうかは決まらない
- ✓ 効く人を先に見分ける方法も、まだ見つかっていない
- ✓ ただし高熱・強い痛み・いったん良くなってからの悪化は、抗生物質を考える理由になる
- ✓ 怖い合併症は早い時期に起き、抗生物質では防げない
- ✓ 防ぐのは「目のまわり」と「おでこ」のサインを知っていること
- ✓ そして最後にもうひとつ。「蓄膿の頭痛」は決めつけない
- ✓ 片頭痛のこともある



ご視聴にあたってのお願い

この動画は**一般的な情報の整理**であり、
個別の診断や治療の指示ではありません。
症状の程度や持病によって判断は変わります。
実際の治療については、
かかりつけの医師にご相談ください。

※この動画は大人の話です。子どもの副鼻腔炎は
抗生物質の考え方が異なるため扱っていません。

この動画の参考資料

[1] 厚生労働省『抗微生物薬適正使用の手引き』第四版(2026年)

[2] EPOS 2020(ヨーロッパの鼻副鼻腔炎の国際文書)

Fokkens WJ, et al. Rhinology. 2020;58(Suppl S29):1-464.

[3] 国際頭痛分類 第3版(ICHHD-3・2018年)

Cephalalgia. 2018;38(1):1-211.

詳しい出典は、概要欄とブログ記事に記載しています。

+ 医知創造ラボ

高評価とチャンネル登録を お願いします

それでは、また次の動画でお会いしましょう



チャンネル登録



高評価